

03

末梢神経症状(CIPN)

しびれの評価と生活の安全

1 薬剤の分類マップ

微小管阻害薬

微小管を阻害し軸索輸送を障害

タキサン系

パクリタキセル nab-パクリタキセル ドセタキセル

ビンカルカロイド系

ビンクリスチン ビノレルビン その他 エリブリン

白金製剤

後根神経節に蓄積して障害

急性と慢性の2つの型

オキサリプラチン 累積量で増加(難聴も) シスプラチン

骨髄腫・リンパ腫等の治療

神経への直接作用・微小管阻害

プロテアソーム阻害薬

ボルテゾミブ 免疫調節薬 サリドマイド

ADC(MMAE搭載)

ブレンツキシマブ ベドチン エンホルツマブ ベドチン

対症療法・予防の工夫

痛み・しびれの緩和

痛みを伴うCIPN

デュロキシセチン 神経障害性疼痛 プレガバリン ミロガバリン

予防・投与法の工夫

冷却・圧迫療法 減量・休薬

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 重症度(CTCAE Grade)と保険薬局での対応

軽い — 重症度 — 重い

Grade1

状態(感覚性の神経障害)

症状はあるが、生活に支障はない

聞き取りで分かる生活の目安

しびれはあるが、ボタンかけや字を書くことは問題ない

保険薬局での対応

同じ質問で経過を記録し、次回と比較

Grade2

状態(感覚性の神経障害)

身の回り以外の日常生活が制限される

聞き取りで分かる生活の目安

料理・買い物・パソコン操作・小銭の扱いがしにくい

保険薬局での対応

処方医へ情報提供(減量・休薬の判断材料)

Grade3

状態(感覚性の神経障害)

身の回りの日常生活が制限される

聞き取りで分かる生活の目安

ボタンがかけられない、着替え・入浴・歩行に支障

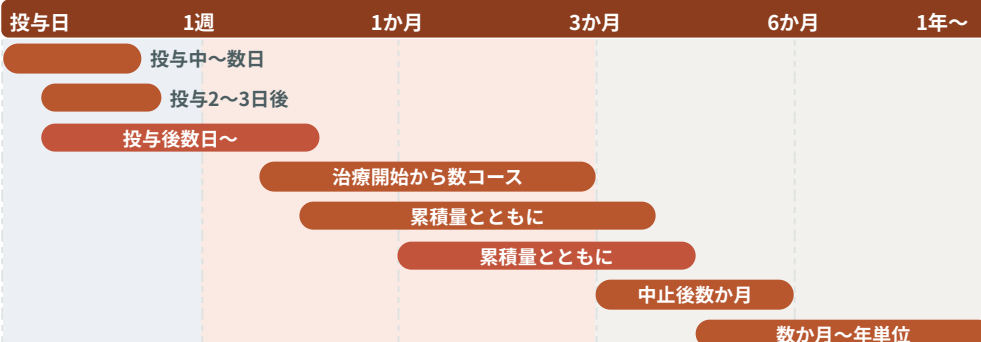
保険薬局での対応

次回投与前に至急情報提供、転倒予防を徹底

運動障害(筋力低下・つまずき)や、急に進む筋力低下は、しびれとは別に確認し、早めに受診を勧める

3 副作用の特徴と発現時期

- オキサリプラチンの急性症状
- パクリタキセルの関節痛・筋肉痛
- ビンクリスチンの便秘・イレウス
- ボルテゾミブのしびれ・痛み
- タキサン系のしびれ
- オキサリプラチンの慢性しびれ
- 中止後の悪化(白金製剤)
- 回復または遷延



☐ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. CIPNは累積量で進み、確実な予防薬はない。早期発見による減量・休薬が最大の対策
2. しびれは具体的な生活動作で聞き取り、毎回同じ質問で前回と比較して評価する
3. 転倒・やけど予防の生活指導と、生活への支障の情報提供が薬局の重要な役割